

低

～250 mg/m²

中

250～400 mg/m²

高

400 mg/m²～

① 本日のポイント

- ☐ 心毒性の分類:急性(投与直後)・慢性(治療後1年以内)・遅発性(1年以降)
- ☐ アントラサイクリン系(ドキシソルビン・エピルビン等)= 不可逆性の高いType I心毒性
- ☐ 用量依存性:ドキシソルビン換算 250mg/m²で中リスク、400mg/m²で高リスク
- ☐ 換算(ESC2022):エピルビン×0.8 / ミトキサントロン×10.5 / イダルビン×5
- ☐ CTRCD重症度分類:LVEF・GLS・バイオマーカーの組み合わせで判定

② 薬剤師の実践ポイント

- ☐ 調剤時に累積投与量(換算後)を確認し、上限接近をチェック
- ☐ 服薬指導で息切れ・むくみ・体重増加を具体的に聴取

TAKE-HOME MESSAGE

用量依存性のType I心毒性。早期発見にはLVEF・GLS・バイオマーカーの両方が役立つ。